PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 5 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

5.1 Reforma Psiquiátrica e legislação

A **Lei nº 10.216/2001** (Lei Paulo Delgado) dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, substituindo o modelo hospitalocêntrico (manicômios) por uma rede de serviços comunitários. A internação, em qualquer modalidade, **só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes**.

Tipos de internação psiquiátrica (art. 6º):

Tipo	Característica
Voluntária	Com o consentimento do usuário (que assina declaração)
Involuntária	Sem o consentimento do usuário, a pedido de terceiro; deve ser **comunicada ao Ministério Público Estadual em até 72 horas** pelo responsável técnico do estabelecimento
Compulsória	Determinada pela **Justiça**

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante **laudo médico circunstanciado** que caracterize seus motivos.

5.2 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Instituída pela **Portaria GM/MS nº 3.088/2011**. Componentes: atenção básica (UBS, equipes de Consultório na Rua, centros de convivência), **atenção psicossocial especializada (CAPS)**, atenção de urgência e emergência (SAMU, UPA), atenção residencial de caráter transitório (unidades de acolhimento, comunidades terapêuticas), atenção hospitalar (leitos de saúde mental em hospital geral), estratégias de desinstitucionalização (**Serviços Residenciais Terapêuticos** e **Programa de Volta para Casa**) e reabilitação psicossocial.

Tipo de CAPS	Público / população
CAPS I	Todas as faixas etárias; municípios com mais de 15 mil habitantes
CAPS II	Transtornos mentais graves e persistentes; mais de 70 mil habitantes
CAPS III	Funcionamento **24 horas**, inclusive fins de semana, com acolhimento noturno; mais de 150 mil habitantes
CAPS AD	Álcool e outras drogas; mais de 70 mil habitantes
CAPS AD III	Álcool e drogas, 24 horas; mais de 150 mil habitantes
CAPS i	Crianças e adolescentes; mais de 70 mil habitantes

5.3 Principais transtornos mentais

- **Esquizofrenia:** sintomas positivos (delírios, alucinações – a mais comum é a auditiva –, discurso desorganizado) e negativos (embotamento afetivo, apatia, isolamento social, alogia).
- **Transtorno afetivo bipolar:** alternância entre episódios de mania (euforia, agitação, redução da necessidade de sono, fuga de ideias, grandiosidade) e de depressão.
- **Depressão:** humor deprimido, anedonia (perda de prazer), alterações de sono e apetite, fadiga, sentimento de culpa, ideação suicida.
- **Transtornos de ansiedade:** ansiedade generalizada, pânico (crises súbitas com palpitação, sudorese, sensação de morte iminente), fobias, transtorno obsessivo-compulsivo.

- **Dependência química:** síndrome de abstinência alcoólica – tremores, sudorese, ansiedade; a forma grave é o **delirium tremens** (confusão, alucinações visuais, agitação, febre), em geral 48 a 72 h após a última dose.

Glossário de psicopatologia: **alucinação** (percepção sem objeto real), **ilusão** (percepção deformada de um objeto real), **delírio** (crença falsa inabalável), **despersonalização**, **logorreia** (fala excessiva), **mutismo**, **ecolalia** (repetição da fala do outro), **catatonia**.

5.4 Psicofármacos e cuidados de enfermagem

Classe	Exemplos	Efeitos adversos a observar
Antipsicóticos típicos	Haloperidol, clorpromazina	Sintomas extrapiramidais (tremor, rigidez, acatisia, distonia), síndrome neuroléptica maligna (febre alta, rigidez, instabilidade autonômica)
Antipsicóticos atípicos	Risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina	Ganho de peso, alterações metabólicas; clozapina – **agranulocitose** (hemograma periódico)
Estabilizador do humor	Carbonato de lítio	**Janela terapêutica estreita** (litemia); intoxicação: tremores grosseiros, vômitos, diarreia, confusão; cuidado com desidratação e dieta pobre em sódio
Antidepressivos	Fluoxetina, sertralina (ISRS); amitriptilina (tricíclico)	Efeito terapêutico demora **2 a 4 semanas**; risco de suicídio no início do tratamento; tricíclicos – boca seca, hipotensão postural, retenção urinária
Ansiolíticos (benzodiazepínicos)	Diazepam, clonazepam	Sonolência, dependência, risco de quedas; antídoto: **flumazenil**

5.5 Assistência de enfermagem

- **Comunicação terapêutica:** escuta ativa, aceitação, linguagem clara, perguntas abertas, não reforçar nem confrontar delírios e alucinações (orientar para a realidade sem discutir).
- **Paciente agitado/agressivo:** ambiente calmo, abordagem verbal (desescalada) como primeira medida, manter distância segura e rota de fuga; a **contenção mecânica** é medida de exceção, por prescrição, por tempo limitado, com monitorização frequente (circulação, sinais vitais, hidratação, eliminações) e registro em prontuário (Resolução COFEN nº 427/2012).
- **Risco de suicídio:** levar a sério qualquer manifestação; perguntar diretamente sobre ideação **não aumenta** o risco; retirar objetos perigosos; supervisão constante; notificação compulsória de tentativa (lesão autoprovocada é de notificação imediata – em até 24 h – no município).
- **Projeto Terapêutico Singular (PTS):** plano construído pela equipe com o usuário e a família.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Lei 10.216/2001 e os três tipos de internação; comunicação ao MP em 72 h na involuntária.
- RAPS (Portaria 3.088/2011) e tipos de CAPS; CAPS III e AD III funcionam 24 h.
- Diferença entre alucinação, ilusão e delírio.
- Efeitos dos antipsicóticos (extrapiramidais) e do lítio (litemia).
- Antidepressivo leva semanas para agir; vigilância do risco de suicídio.

- Contenção mecânica como último recurso, com monitorização e registro.
- Perguntar sobre suicídio não induz o ato.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"VIC"**: Voluntária (eu quero), Involuntária (outro pede – MP em 72 h), Compulsória (juiz manda).
- **"CAPS III é o único que não dorme"** (junto com o AD III).
- **"Alucinação não tem objeto; ilusão deforma o objeto; delírio é ideia"**.
- **"Lítio pede sangue"**: controle de litemia.
- **"Clozapina conta leucócitos"**: risco de agranulocitose.
- **"Primeiro conversa, depois contém"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

De acordo com a Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica que ocorre sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro denomina-se:

(A) voluntária, devendo ser comunicada ao Conselho Tutelar.
(B) compulsória, determinada pelo médico assistente.
(C) involuntária, devendo ser comunicada ao Ministério Público Estadual no prazo de 72 horas.
(D) involuntária, dispensando qualquer comunicação.
(E) compulsória, comunicada ao COFEN em 24 horas.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a voluntária ocorre com o consentimento do usuário.

B) Incorreta – a compulsória é determinada pela Justiça.

C) Correta – a internação involuntária deve ser comunicada ao MP Estadual em até 72 horas pelo responsável técnico do estabelecimento.

D) Incorreta – a comunicação ao MP é obrigatória.

E) Incorreta – o órgão e a modalidade estão errados.

QUESTÃO 02

Na Rede de Atenção Psicossocial, o serviço que funciona 24 horas, inclusive nos feriados e fins de semana, com acolhimento noturno, destinado a pessoas com transtornos mentais graves, é o:

(A) CAPS I.
(B) CAPS II.
(C) CAPS III.
(D) CAPS i.
(E) Centro de Convivência.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o CAPS I funciona em horário comercial.

B) Incorreta – o CAPS II funciona em dois turnos, de segunda a sexta (podendo ter terceiro turno até 21 h).

C) Correta – o CAPS III é o serviço 24 horas para transtornos mentais (o AD III é o correspondente para álcool e drogas).

D) Incorreta – o CAPS i atende crianças e adolescentes, sem funcionamento 24 h obrigatório.

E) Incorreta – o centro de convivência é espaço de sociabilidade da atenção básica, não serviço 24 h.

QUESTÃO 03

Paciente em uso de carbonato de lítio apresenta vômitos, diarreia, tremores grosseiros e confusão mental. O técnico em enfermagem deve suspeitar de:

(A) síndrome de abstinência alcoólica.
(B) intoxicação por lítio, comunicando a equipe para avaliação da litemia.
(C) efeito terapêutico esperado do medicamento.
(D) agranulocitose.
(E) hipoglicemia.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o quadro é compatível com o uso do lítio, não com abstinência.

B) Correta – o lítio tem janela terapêutica estreita; sintomas gastrintestinais, tremores grosseiros e confusão indicam intoxicação.

C) Incorreta – esses sinais não são efeito esperado.

D) Incorreta – a agranulocitose é associada principalmente à clozapina.

E) Incorreta – não há relação com o quadro descrito.

QUESTÃO 04

Um paciente relata ouvir vozes que o mandam sair do quarto, sem que ninguém esteja falando. Esse fenômeno é chamado de:

(A) ilusão.
(B) delírio.
(C) alucinação auditiva.
(D) ecolalia.
(E) logorreia.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – ilusão é a percepção deformada de um estímulo real.

B) Incorreta – delírio é alteração do pensamento (crença falsa), não da percepção.

C) Correta – perceber vozes sem estímulo real é alucinação auditiva, comum na esquizofrenia.

D) Incorreta – ecolalia é a repetição da fala de outra pessoa.

E) Incorreta – logorreia é a fala excessiva.

QUESTÃO 05

Sobre a assistência ao paciente com risco de suicídio, é correto afirmar:

(A) perguntar diretamente sobre ideação suicida aumenta o risco e deve ser evitado.
(B) quem fala que vai se matar não o faz, apenas quer chamar atenção.
(C) a melhora súbita do humor no início do tratamento antidepressivo elimina o risco.
(D) a supervisão, a retirada de objetos perigosos e a escuta acolhedora fazem parte dos cuidados.
(E) a tentativa de suicídio não é de notificação compulsória.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – perguntar abertamente não induz o ato e ajuda a avaliar o risco.

B) Incorreta – é um mito; toda manifestação deve ser levada a sério.

C) Incorreta – o início do tratamento é período de risco elevado, pois a energia volta antes do humor.

D) Correta – supervisão, ambiente seguro e escuta são cuidados essenciais.

E) Incorreta – a violência autoprovocada, incluindo tentativa de suicídio, é de notificação compulsória imediata.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: Reforma Psiquiátrica e Lei 10.216/2001; tipos de internação; RAPS e CAPS; transtornos (esquizofrenia, bipolar, depressão, ansiedade, dependência química); psicopatologia; psicofármacos; comunicação terapêutica; contenção; risco de suicídio; PTS.

Quadro-resumo: internação involuntária – MP em 72 h; CAPS III e AD III – 24 h; antidepressivo – efeito em 2 a 4 semanas; lítio – litemia; clozapina – hemograma; flumazenil – antídoto dos benzodiazepínicos.

Pegadinhas: confundir compulsória com involuntária; achar que perguntar sobre suicídio é perigoso; trocar alucinação por ilusão.

Erros comuns: tratar contenção como primeira escolha; discutir com o paciente sobre o conteúdo do delírio.